

Trastornos del espectro autista (TEA)

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

PRONAP 2018 Módulo 2

DSM - 5

Los trastornos del espectro autista (TEA) son cuadros que afectan el neurodesarrollo cerebral temprano y que comprometen principalmente la interacción social, la comunicación, el procesamiento de los estímulos sensoriales y la flexibilidad (capacidad de aceptar/tolerar los cambios en el entorno y adaptarse a ellos).

Detección

La intervención temprana mejora el pronóstico del niño o niña, mejora la calidad de vida de la familia y reduce los costos asociados a los tratamientos. Algunos niños que han recibido intervención temprana, en el mediano plazo no cumplen más los criterios diagnósticos de TEA. El mecanismo que subyace a la efectividad de la intervención temprana está relacionado con la neuroplasticidad que existe en los primeros años de vida.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) sugiere hacer pesquisas sistemáticas de TEA en los controles pediátricos de niños.

Existen herramientas específicas para hacerlo, como el M-CHAT-R.

Fisiopatología

1. Tienen evidencias de su origen genético: actualmente hay varios genes identificados.
2. No son motivados por sucesos de vida o alteraciones vinculares con padres o cuidadores.
3. Comienzan a manifestarse muy tempranamente con alteraciones en la interacción, en el uso del lenguaje verbal y no verbal, en la manipulación de objetos comunes y en el comportamiento frente a los estímulos sensoriales.

Presenta trastornos fundamentalmente cualitativos en las siguientes áreas:

1. Reciprocidad socio-emocional

Se manifiestan con algunas conductas tales como:

- a. Aparente indiferencia ante los acercamientos comunes de los demás.
- b. No presentan intereses y ni realizan actividades compartidas. Prefiere hacer cosas por su cuenta antes, excepto juegos corporales o de secuencias conocidas de movimientos.
- c. No saludan espontáneamente o no responden al saludo. No buscan consuelo cuando les pasa algo, aunque puedan ser sensibles a la contención del adulto. Tampoco se aproximan a consolar a otros.
- d. No evidencian conductas de imitación social inmediata o solicitada. Pero pueden aparecer conductas que indican imitación diferida, tanto a personas reales como a personajes de TV.
- e. Les faltan las capacidades necesarias para hacer o sostener una amistad.
- f. Presentan falta de reconocimiento o de atención a reglas sociales. Algunos pueden aprender reglas, pero les cuesta adecuarlas al contexto real de aplicación.

2. Trastornos en la comunicación

- a. Con ausencia de lenguaje verbal en más del 50% de los casos (por pérdida o falta de desarrollo).
- b. Con dificultades para usar socialmente el lenguaje verbal (aunque lo tengan) de manera flexible: cada palabra tiene uno y sólo un significado.
- c. La comprensión parece ser más lenta o bien estar focalizada en algún aspecto, como si de toda una frase se tomara como referencia: a) una sola palabra a la que se le asigna el significado del todo, o b) la entonación o el acento, independientemente del significado asignado por el hablante.

- d. Tienden a usar frases aprendidas globalmente con entonaciones ajenas a la situación del momento.
- c. Algunos presentan claros acentos extraños a los que se usan en su contexto, como si fueran extranjeros.

3. Trastornos en el desempeño cotidiano:

a. Estereotipias motoras: movimientos y/o conductas usuales o extrañas con falta de funcionalidad; algunas parecen relacionadas con estados de ánimo. Es común que un niño dé vueltas a un autito en miniatura para hacerle girar la rueda, pero no lo es que sólo haga ese movimiento durante largo rato. También es frecuente que quiera ver una película más de una vez, pero no lo es que quiera verla ininterrumpidamente una y otra vez durante horas, días, semanas y meses.

b. Conductas sensoriales o motoras anormales: reacciones inesperadas a ruidos y sonidos, voces humanas, olores, luces, colores, etc. Producción monótona de sonidos o ruidos, acercamiento gustativo u olfativo a objetos, etc.

3. Preocupaciones con ciertos objetos o partes de ellos: focalización de la atención en algún atributo del objeto o en el uso selectivo, para repetir algún patrón de acción muchas veces disfuncional.

4. Reacciones de estrés intenso con desorganización de la conducta: cuando lo que espera que suceda y lo que sucede realmente, no coinciden.

5. Rutinas fijas, muy rígidas y difíciles de modificar: una vez aprendido un patrón de resolución, lo repiten siempre de la misma manera sin posibilidades de adaptación a las variaciones del contexto.

6. Intereses restringidos y/o perseverativos: aparentemente la atención es canalizada a los patrones aprendidos y repetidos.

7. Ausencia de interés espontáneo en actividades comunes para otros niños.

8. Trastornos en el juego simbólico.

M-CHAT-R

Es válido para cribar niños de entre 16 y 30 meses de edad, para evaluar el riesgo de Trastornos del Espectro Autista (TEA). Los usuarios deben ser conscientes de que incluso con la entrevista, un número significativo de niños que no pasen el M-CHAT-R no serán diagnosticados de TEA. No obstante, estos niños siguen en riesgo de padecer otros trastornos o retrasos en el desarrollo.

Para todos los ítems, excepto el 2, 5 y 12, la respuesta "NO " indica riesgo de TEA; para los ítems 2, 5, y 12, "Sí " indica riesgo de TEA.

Riesgo según puntuación total

Bajo riesgo: Puntuación total entre 0-2. Si el niño es menor de 24 meses, repetir MCHAT-R a los 24m. Ninguna otra medida necesaria a menos que la vigilancia del desarrollo indique riesgo de TEA.

Riesgo medio:

- Puntuación total entre 3-7. Administrar la entrevista de seguimiento para obtener información adicional acerca de las respuestas de riesgo. Si la puntuación M-CHAT-R/F se mantiene en 2 o superior, el niño ha resultado positivo. Medida necesaria: remita al niño para una evaluación diagnóstica y para determinar necesidad de atención temprana.
- Si la puntuación es 0-1, el niño ha resultado negativo. Ninguna otra medida es necesaria a menos que la vigilancia del desarrollo indique riesgo de TEA. El niño debe seguir vigilado en futuras visitas del programa del niño sano.

Riesgo alto:

Puntuación total entre 8-20. Es aceptable prescindir de la entrevista de seguimiento y se debe remitir el caso de inmediato para evaluación diagnóstica y para determinar necesidad de intervención temprana.

Paciente:
 Edad:Fecha:

Por favor responda a estas preguntas sobre su hijo/a. Tenga en cuenta **cómo su hijo/a se comporta habitualmente**. Si usted ha visto a su hijo/a comportarse de una de estas maneras algunas veces, pero no es un comportamiento habitual, por favor responda **no**. Seleccione, rodeando con un círculo, Muchas gracias.

1. Si usted señala algo al otro lado de la habitación, ¿su hijo/a lo mira? (POR EJEMPLO, Si usted señala a un juguete, un peluche o un animal, ¿su hijo/a lo mira?)	SÍ	NO
2. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo/a es sordo/a?	SÍ	NO
3. ¿Su hijo/a juega juegos de fantasía o imaginación? (POR EJEMPLO, “hace como que” bebe de una taza vacía, habla por teléfono o da de comer a una muñeca o peluche,...)	SÍ	NO
4. ¿A su hijo le gusta subirse a cosas? (POR EJEMPLO, a una silla, escaleras, o tobogán,...)	SÍ	NO
5. ¿Hace su hijo/a movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? (POR EJEMPLO, mueve sus dedos cerca de sus ojos de manera inusual?)	SÍ	NO
6. ¿Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda? (POR EJEMPLO, señala un juguete o algo de comer que está fuera de su alcance?)	SÍ	NO
7. Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención? (POR EJEMPLO, señala un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle)	SÍ	NO
8. ¿Su hijo/a se interesa en otros niños? (POR EJEMPLO, mira con atención a otros niños, les sonríe o se les acerca?)	SÍ	NO
9. ¿Su hijo/a le muestra cosas acercándolas o levantándolas para que usted las vea – no para pedir ayuda sino solamente para compartirlas con usted? (POR EJEMPLO, le muestra una flor o un peluche o un coche de juguete)	SÍ	NO
10. ¿Su hijo/a responde cuando usted le llama por su nombre? (POR EJEMPLO, se vuelve, habla o balbucea, o deja de hacer lo que estaba haciendo para mirarle?)	SÍ	NO
11. ¿Cuándo usted sonríe a su hijo/a, él o ella también le sonríe?	SÍ	NO
12. ¿Le molestan a su hijo/a ruidos cotidianos? (POR EJEMPLO, la aspiradora o la música, incluso cuando está no está excesivamente alta?)	SÍ	NO
13. ¿Su hijo/a camina solo?	SÍ	NO
14. ¿Su hijo/a le mira a los ojos cuando usted le habla, juega con él o ella, o lo viste?	SÍ	NO
15. ¿Su hijo/a imita sus movimientos? (POR EJEMPLO, decir adiós con la mano, aplaudir o algún ruido gracioso que usted haga?)	SÍ	NO
16. Si usted se gira a ver algo, ¿su hijo/a trata de mirar hacia lo que usted está mirando?	SÍ	NO
17. ¿Su hijo/a intenta que usted le mire/preste atención? (POR EJEMPLO, busca que usted le haga un cumplido, o le dice “mira” ó “mírame”)	SÍ	NO
18. ¿Su hijo/a le entiende cuando usted le dice que haga algo? (POR EJEMPLO, si usted no hace gestos, ¿su hijo/a entiende “pon el libro encima de la silla” o “tráeme la manta”?)	SÍ	NO
19. Si algo nuevo pasa, ¿su hijo/a le mira para ver como usted reacciona al respecto? (POR EJEMPLO, si oye un ruido extraño o ve un juguete nuevo, ¿se gira a ver su cara?)	SÍ	NO
20. Le gustan a su hijo/a los juegos de movimiento? (POR EJEMPLO, le gusta que le balancee, o que le haga “el caballito” sentándole en sus rodillas)	SÍ	NO

Paciente:

Edad:Fecha:

Entrevista de Seguimiento al M-CHAT-R/F™ Hoja de Puntuación

Por favor tenga en cuenta: Sí/No han sido sustituidos por Pasa/No Pasa

1. Si usted señala algo al otro lado de la habitación, ¿su hijo/a lo mira? (POR EJEMPLO, Si usted señala a un juguete, un peluche o un animal, ¿su hijo/a lo mira?)	Pasa	No Pasa
2. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo/a es sordo/a?	Pasa	No Pasa
3. ¿Su hijo/a juega juegos de fantasía o imaginación? (POR EJEMPLO, “hace como que” bebe de una taza vacía, habla por teléfono o da de comer a una muñeca o peluche,...)	Pasa	No Pasa
4. ¿A su hijo le gusta subirse a cosas? (POR EJEMPLO, a una silla, escaleras, o tobogán,...)	Pasa	No Pasa
5. ¿Hace su hijo/a movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? (POR EJEMPLO, mueve sus dedos cerca de sus ojos de manera inusual)	Pasa	No Pasa
6. ¿Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda? (POR EJEMPLO, señala un juguete o algo de comer que está fuera de su alcance?)	Pasa	No Pasa
7. Su hijo/a señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención? (POR EJEMPLO, señala un avión en el cielo o un camión muy grande en la calle)	Pasa	No Pasa
8. ¿Su hijo/a se interesa en otros niños? (POR EJEMPLO, mira con atención a otros niños, les sonríe o se les acerca?)	Pasa	No Pasa
9. ¿Su hijo/a le muestra cosas acercándolas o levantándolas para que usted las vea – no para pedir ayuda sino solamente para compartirlas con usted? (POR EJEMPLO, le muestra una flor o un peluche o un coche de juguete)	Pasa	No Pasa
10. ¿Su hijo/a responde cuando usted le llama por su nombre? (POR EJEMPLO, se vuelve, habla o balbucea, o deja de hacer lo que estaba haciendo para mirarle?)	Pasa	No Pasa
11. ¿Cuándo usted sonríe a su hijo/a, él o ella también le sonríe?	Pasa	No Pasa
12. ¿Le molestan a su hijo/a ruidos cotidianos? (POR EJEMPLO, la aspiradora o la música, incluso cuando está no está excesivamente alta?)	Pasa	No Pasa
13. ¿Su hijo/a camina solo?	Pasa	No Pasa
14. ¿Su hijo/a le mira a los ojos cuando usted le habla, juega con él o ella, o lo viste?	Pasa	No Pasa
15. ¿Su hijo/a imita sus movimientos? (POR EJEMPLO, decir adiós con la mano, aplaudir o algún ruido gracioso que usted haga?)	Pasa	No Pasa
16. Si usted se gira a ver algo, ¿su hijo/a trata de mirar hacia lo que usted está mirando?	Pasa	No Pasa
17. ¿Su hijo/a intenta que usted le mire/preste atención? (POR EJEMPLO, busca que usted le haga un cumplido, o le dice “mira” ó “mírame”)	Pasa	No Pasa
18. ¿Su hijo/a le entiende cuando usted le dice que haga algo? (POR EJEMPLO, si usted no hace gestos, ¿su hijo/a entiende “pon el libro encima de la silla” o “tráeme la manta”?)	Pasa	No Pasa
19. Si algo nuevo pasa, ¿su hijo/a le mira para ver como usted reacciona al respecto? (POR EJEMPLO, si oye un ruido extraño o ve un juguete nuevo, ¿se gira a ver su cara?)	Pasa	No Pasa
20. Le gustan a su hijo/a los juegos de movimiento? (POR EJEMPLO, le gusta que le balancee, o que le haga “el caballito” sentándole en sus rodillas)	Pasa	No Pasa

Puntuación Total _____

Diagnóstico diferencial

El planteo para realizar los diagnósticos diferenciales variará de acuerdo a cuál sea el “signo eje”:

Signo eje	Diagnóstico diferencial
Aislamiento	Habría que realizar diagnóstico diferencial con trastorno reactivo de vinculación en la infancia, depresión, trastornos por estrés agudo, mutismo selectivo.
Pérdida de funciones adquiridas	Los diagnósticos diferenciales más importantes serán: afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau Kleffner), síndrome de Rett (SR) y el trastorno degenerativo infantil.
Lenguaje	Se debe realizar el diagnóstico diferencial con trastornos del lenguaje y con Trastorno Específico del Lenguaje con signos de disfunción social emocional (TELplus).
Nivel cognitivo	El diagnóstico diferencial más importante es con retraso mental (RM).
Autoagresión	Se puede encontrar en RM, cuadros metabólicos, con situaciones ambientales, con condiciones somáticas, con otros cuadros psiquiátricos, TOC severos.
Movimientos anormales	Es necesario hacer diagnóstico diferencial ante la posibilidad de que sean parte de trastornos asociados, trastorno por tics múltiples o bien por tratamientos farmacológicos.
Rituales y otras conductas compulsivas	El diagnóstico diferencial es con TOC y Tourette.

Disfunción emocional y social precoz

Conducta aislada o asociada a otras, que puede presentar un niño:

- Antes del año y medio de vida.
- En presencia de familiares y extraños.
- Sólo a veces relacionadas temporalmente con sucesos de vida compatibles con algún tipo de privación sensorial y/o social.
- Sin etiologías identificables en el momento de la ocurrencia de las mismas.
- Sin constituir una entidad nosológica compatible con las clasificaciones de referencia (DSM o CIE).
- Es indicio para la exploración nosológica.
- Es un diagnóstico de transición para el primer año de vida.
- Un sólo signo es indicación para la intervención activa inmediata: exploración e intervención sea terapéutica, educativa o de estimulación.
- No siempre reconoce una etiología conocida.
- No evoluciona necesariamente a TEA.

Algunas de dichas conductas pueden ser cosintomáticas (acompañando a trastornos identificables).

Para su diagnóstico son necesarios algunos signos directos como:

Trastornos en la co-ritmicidad cotidiana: esperable entre los padres y el niño en las actividades básicas ya desde el momento del nacimiento, sin ajustes en el segundo trimestre: alimentación, sueño, juegos, vocalizaciones.

Ausencia o escasa frecuencia de conductas de solicitud (miradas, vocalizaciones), anticipación (miradas, extensión de los brazos) y respuesta a la aproximación.

Falta de adaptación corporal al ser sostenido en brazos con posturas que van desde la percepción de molestia, hasta el llanto o arqueado dorsal.

Falta de reciprocidad ante la estimulación que el adulto le hace al niño en conductas tales como: movimientos de labios, sonidos, movimientos de manos sincrónicos con canciones (imitación por modelado simultáneo).

Aparente retraso de vocalizaciones tanto espontáneas como de respuesta.

Pueden presentar algunos signos indirectos:

Predominio de conductas sin contenido funcional o evolutivo aparente: balanceos, giros continuos de cabeza, desplazamientos sin metas aparentes, sonidos vocales sin apariencia de ejercicio, juego o búsqueda de respuesta.

Alta frecuencia de conductas puramente sensoriales repetitivas y no evolutivas.

Patrones motores fijos sin adaptaciones ante los cambios contextuales y madurativos.

Dificultades en el cambio de foco atencional: falta de interés ante la novedad, falta de evolución de conductas anticipatorias, demora o ausencia de aceptación de comidas nuevas.

Retraso mental

A menudo coexisten con el TGD. Normalmente en el retraso mental, los factores sociales y comunicativos se encuentran en niveles esperados dado el desarrollo general del niño. Los individuos con retraso mental severo y profundo pueden mostrar varios rasgos parecidos al autismo, concretamente movimientos estereotipados. El retraso mental no suele observarse asociado al trastorno de Asperger.

Trastornos del desarrollo específicos

Particularmente los trastornos de lenguaje, en los que los déficits principales se encuentran en el área de comunicación / lenguaje, los factores sociales son normalmente mantenidos y los intereses restringidos inusuales y los comportamientos asociados con el autismo no están presentes.

Esquizofrenia

Rara vez tiene su comienzo en la niñez. Normalmente existe una historia previa de desarrollo normal o casi normal, con el inicio de las alucinaciones e ideas delirantes características.

Mutismo selectivo

A veces se confunde con el autismo y los trastornos asociados. En el mutismo selectivo la habilidad del niño para hablar en algunas situaciones se mantiene, pero el niño está mudo en otras situaciones. La historia y la presentación son bastante diferentes de los autistas. En los casos donde los niños con autismo son mudos, su mutismo no es selectivo.

Trastorno de fobia social

Puede a veces confundirse con el autismo u otro TGD (en concreto, TGD-NOS), pero en ese caso los otros criterios del autismo no estarían presentes.

Trastorno de movimiento estereotipado

Se caracteriza por los manierismos motores (estereotipos) y la presencia de retraso mental, pero no se puede hacer el diagnóstico si cumple algún criterio para alguno de los TGD.

Demencia

En alguna ocasión tiene su comienzo durante la niñez, pero va asociada a alguna causa orgánica aunque muestre criterios para el trastorno desintegrativo infantil.

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Algunos niños muestran normalmente intereses y comportamientos poco usuales. Sin embargo, se mantienen los factores sociales, el lenguaje y la comunicación.

Trastorno de personalidad esquizoide

El individuo se puede aislar en algunos contextos pero tiene la habilidad de relacionarse con normalidad en otros.

Trastorno de personalidad por evitación

Está caracterizado por la ansiedad a la hora de afrontar ciertas situaciones sociales.

Tratamiento

El tratamiento es complejo y debe abarcar todas las áreas del desarrollo involucradas. El diagnóstico nosológico en sí mismo no nos aporta datos suficientes.

El diseño debe hacerse en forma individualizada de acuerdo a la configuración conductual, las modalidades comunicativas, relacionales, de aprendizaje y de control del desempeño, además de las características sensoriales, ejecutivo y lingüístico (desarrollo, modalidades de adquisición y de organización).

El tratamiento es multimodal.